Arztbrief — tuzilish, iboralar, namunalar

Arztbrief: структура, фразы, образцы · FSP 2-qism

Tuzilish · Структура

1. **Anrede** — „Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,“
2. **Einleitung** — „wir berichten über Ihren Patienten ..., der sich am ... in unserer Notaufnahme vorstellte.“
3. **Anamnese** — shikoyat, boshlanishi, hamroh simptomlar, kasalliklar, dorilar, allergiya, Noxen · жалоба, начало, симптомы, болезни, лекарства, аллергии, Noxen
4. **Befunde** — ko‘rik, laboratoriya, EKG, tasvirlash · осмотр, лаборатория, ЭКГ, визуализация
5. **Diagnose** — (taxminiy) tashxis, DD · (предварительный) диагноз, ДД
6. **Therapie und Verlauf** — nima qilindi · что сделано
7. **Procedere / Empfehlung** — tavsiyalar · рекомендации
8. **Grußformel** — „Mit freundlichen kollegialen Grüßen“

Qisqa, aniq gaplar; anamnez uchun Präteritum va passiv; dorilar doza bilan („Ramipril 5 mg 1-0-0“).
Короткие ясные предложения; для анамнеза — Präteritum и пассив; лекарства с дозой.

Arztbrief – Einleitung und Anamnese

Deutsch	O‘zbekcha	Русский
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,	Hurmatli hamkasblar,	Уважаемые коллеги,
wir berichten über Ihren Patienten Herrn ..., geb. am ..., der sich vom ... bis zum ... in unserer stationären Behandlung befand.	... dan ... gacha bizda statsionar davolangan bemoringiz janob ... haqida xabar beramiz.	сообщаем о вашем пациенте господине ..., дата рождения ..., который находился на стационарном лечении у нас с ... по ....
Der Patient stellte sich mit seit ... bestehenden ... in unserer Notaufnahme vor.	Bemor ... dan beri davom etayotgan ... bilan shoshilinch bo‘limimizga murojaat qildi.	Пациент обратился в наше приёмное отделение с ... , существующими с ... .
Begleitend bestanden ...	Qo‘shimcha ravishda ... kuzatildi.	Сопутствующе отмечались ...
... wurde verneint.	... inkor qilindi (bemorda yo‘q).	... отрицалось.

Arztbrief – Befunde, Diagnose, Procedere

Deutsch	O‘zbekcha	Русский
Bei der körperlichen Untersuchung zeigte sich ...	Fizikal ko‘rikda ... aniqlandi.	При физикальном обследовании выявлено ...

Deutsch	O‘zbekcha	Русский
Laborchemisch fand sich ein erhöhtes ...	Laboratoriyada ... ko‘tarilgani aniqlandi.	Лабораторно определялся повышенный ...
Im EKG zeigten sich ...	EKG‘da ... kuzatildi.	На ЭКГ выявлено ...
Sonographisch stellte sich ... dar.	Sonografiyada ... aniqlandi.	При УЗИ визуализировался ...
Wir stellten die Diagnose ...	Biz ... tashxisini qo‘ydik.	Мы поставили диагноз ...

Arztbrief – Therapie, Verlauf und Entlassung

Deutsch	O‘zbekcha	Русский
Unter der eingeleiteten Therapie mit ... besserte sich der Allgemeinzustand rasch.	Boshlangan ... terapiyasi fonida umumiy holat tez yaxshilandi.	На фоне начатой терапии ... общее состояние быстро улучшилось.
Der weitere stationäre Verlauf gestaltete sich komplikationslos.	Kasalxonadagi keyingi kechish asoratsiz o‘tdi.	Дальнейшее течение в стационаре было без осложнений.
Die Entzündungsparameter waren im Verlauf rückläufig.	Yallig‘lanish ko‘rsatkichlari keyinchalik pasaydi.	Воспалительные показатели в динамике снизились.
Wir konnten den Patienten in gutem Allgemeinzustand nach Hause entlassen.	Bemorni yaxshi umumiy holatda uyiga javob berdik.	Мы выписали пациента домой в хорошем общем состоянии.
Die Medikation wurde wie folgt angepasst: ...	Dori-darmonlar quyidagicha o‘zgartirildi: ...	Медикаментозная терапия была скорректирована следующим образом: ...

Arztbrief – Körperlicher Untersuchungsbefund

Deutsch	O‘zbekcha	Русский
Bei Aufnahme präsentierte sich ein ... -jähriger Patient in reduziertem Allgemeinzustand und adipösem Ernährungszustand.	Qabul qilinganda ... yoshli bemor umumiy ahvoli pasaygan va semizlik holatida edi.	При поступлении ... -летний пациент в сниженном общем состоянии, повышенного питания.
Der Patient war wach, allseits orientiert und kooperativ.	Bemor hushida, to‘liq mo‘ljalli va hamkorlikka tayyor edi.	Пациент в сознании, полностью ориентирован, контактен.
Herz: Herztöne rein, rhythmisch, keine pathologischen Geräusche.	Yurak: tonlari toza, ritmik, patologik shovqinlar yo‘q.	Сердце: тоны ясные, ритмичные, патологических шумов нет.
Lunge: vesikuläres Atemgeräusch beidseits, keine Rasselgeräusche.	O‘pka: ikki tomonda vezikulyar nafas, xirillashlar yo‘q.	Лёгкие: везикулярное дыхание с обеих сторон, хрипов нет.
Abdomen: weich, Druckschmerz im rechten Unterbauch, keine Abwehrspannung, Darmgeräusche regelrecht.	Qorin: yumshoq, o‘ng pastki qismda bosganda og‘riq, mushak himoyasi yo‘q, ichak shovqinlari normal.	Живот: мягкий, болезненный в правой подвздошной области, без мышечной защиты, перистальтика нормальная.

Arztbrief – Empfehlungen und Medikation

Deutsch	O‘zbekcha	Русский
Wir bitten um Fortführung der Medikation wie im Entlassungsplan aufgeführt.	Chiqarish rejasida ko‘rsatilganidek dorilarni davom ettirishni so‘raymiz.	Просим продолжить терапию согласно плану выписки.
Die Medikation wurde wie folgt umgestellt: ...	Dori rejimi quyidagicha o‘zgartirildi: ...	Терапия была изменена следующим образом: ...
Neu angesetzt wurde ..., abgesetzt wurde ...	Yangi tayinlandi: ..., to‘xtatildi: ...	Впервые назначено ..., отменено ...
Wir empfehlen eine Kontrolle der Nierenwerte und Elektrolyte in einer Woche.	Bir haftadan keyin buyrak ko‘rsatkichlari va elektrolitlarni tekshirishni tavsiya qilamiz.	Рекомендуем контроль почечных показателей и электролитов через неделю.
Eine Wiedervorstellung in unserer Ambulanz ist am ... vorgesehen.	... sanada ambulatoriyamizga qayta kelish rejalashtirilgan.	Повторный визит в нашу амбулаторию запланирован на ...

Namuna 1 · Образец 1

Akuter Myokardinfarkt (STEMI)

- Patient: Klaus Weber, 58 Jahre, männlich
- Aufnahme: 02.10.2026, Notaufnahme
- Seit 2 h drückende retrosternale Thoraxschmerzen, Ausstrahlung in den linken Arm, Kaltschweißigkeit, Nausea
- Vorerkrankungen: arterielle Hypertonie, Hypercholesterinämie
- Medikation: Ramipril 5 mg 1-0-0, Simvastatin 20 mg 0-0-1
- Allergie: Penicillin
- Noxen: Nikotinabusus ca. 30 pack years
- EKG: ST-Streckenhebungen in II, III, aVF
- Labor: Troponin T erhöht
- Therapie: ASS, Heparin, Morphin; Koronarangiographie mit PCI und Stentimplantation der RCA

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten über Ihren Patienten Herrn Klaus Weber, 58 Jahre, der sich am 02.10.2026 in unserer Notaufnahme vorstellte.

Anamnese:
Der Patient stellte sich mit seit ca. zwei Stunden bestehenden, drückenden retrosternalen Thoraxschmerzen mit Ausstrahlung in den linken Arm vor. Begleitend bestanden Kaltschweißigkeit und Nausea. An Vorerkrankungen sind eine arterielle Hypertonie und eine Hypercholesterinämie bekannt. Es besteht ein Nikotinabusus von ca. 30 pack years. Allergie: Penicillin.

Befunde:
Im EKG zeigten sich ST-Streckenhebungen in den Ableitungen II, III und aVF. Laborchemisch war das Troponin T erhöht.

Diagnose:
Akuter inferiorer ST-Hebungsinfarkt (STEMI).

Therapie und Verlauf:
Nach Gabe von ASS, Heparin und Morphin erfolgte eine notfallmäßige Koronarangiographie mit PCI und Stentimplantation der rechten Koronararterie (RCA). Der weitere Verlauf gestaltete sich komplikationslos.

Procedere:
Wir empfehlen eine duale Thrombozytenaggregationshemmung für 12 Monate, die Fortführung der Statintherapie, eine strikte Nikotinkarenz sowie eine kardiologische Rehabilitation.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Namuna 2 · Образец 2

Akute Appendizitis

- Patient: Lukas Schulz, 22 Jahre, männlich
- Aufnahme: 30.09.2026
- Seit gestern Abend Schmerzen periumbilikal, dann Wanderung in den rechten Unterbauch; Nausea, einmalige Emesis, Temperatur 38,3 °C
- Keine Vorerkrankungen, keine Voroperationen
- Untersuchung: Druckschmerz am McBurney-Punkt, Loslassschmerz, positives Psoas-Zeichen
- Labor: Leukozyten 14.500/µl, CRP 45 mg/l
- Sonographie: nicht komprimierbare, verdickte Appendix (9 mm) mit freier Flüssigkeit
- Therapie: laparoskopische Appendektomie am Aufnahmetag, komplikationsloser Verlauf, Entlassung am 3. postoperativen Tag

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten über Ihren Patienten Herrn Lukas Schulz, 22 Jahre, der sich vom 30.09. bis 03.10.2026 in unserer stationären Behandlung befand.

Anamnese:
Der Patient stellte sich mit seit dem Vorabend bestehenden, zunächst periumbilikalen und dann in den rechten Unterbauch gewanderten Schmerzen vor. Begleitend bestanden Nausea, einmalige Emesis sowie eine Temperatur von 38,3 °C. Vorerkrankungen und Voroperationen sind nicht bekannt.

Befunde:
Klinisch zeigten sich ein Druckschmerz am McBurney-Punkt, ein Loslassschmerz sowie ein positives Psoas-Zeichen. Laborchemisch fanden sich eine Leukozytose von 14.500/µl und ein CRP von 45 mg/l. Sonographisch zeigte sich eine nicht komprimierbare, auf 9 mm verdickte Appendix mit freier Flüssigkeit.

Diagnose:
Akute Appendizitis.

Therapie und Verlauf:
Noch am Aufnahmetag erfolgte eine laparoskopische Appendektomie. Der postoperative Verlauf gestaltete sich komplikationslos, sodass wir den Patienten am 3. postoperativen Tag in gutem Allgemeinzustand entlassen konnten.

Procedere:
Wir empfehlen eine Wundkontrolle und die Entfernung des Nahtmaterials am 10. postoperativen Tag sowie körperliche Schonung für zwei Wochen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Bepul mashq qiling · Бесплатная практика
Virtual bemor bilan suhbat, Arztbrief yozish va 3 qismli mashq imtihoni — **osonfsp.github.io**
Беседа с виртуальным пациентом, Arztbrief и пробный экзамен из 3 частей — **osonfsp.github.io**
Har kuni yangi so‘z · Новое слово каждый день: **t.me/osonfsp**

© OsonFSP. Bu qo‘llanmani bepul tarqatishingiz mumkin · Этот материал можно свободно распространять.